Capacidad disponible.
Decisión humana.

Atención verificable.

Una propuesta de piloto institucional acotado y supervisado.



Hay capacidad que no llega a convertirse en atención.

16.543

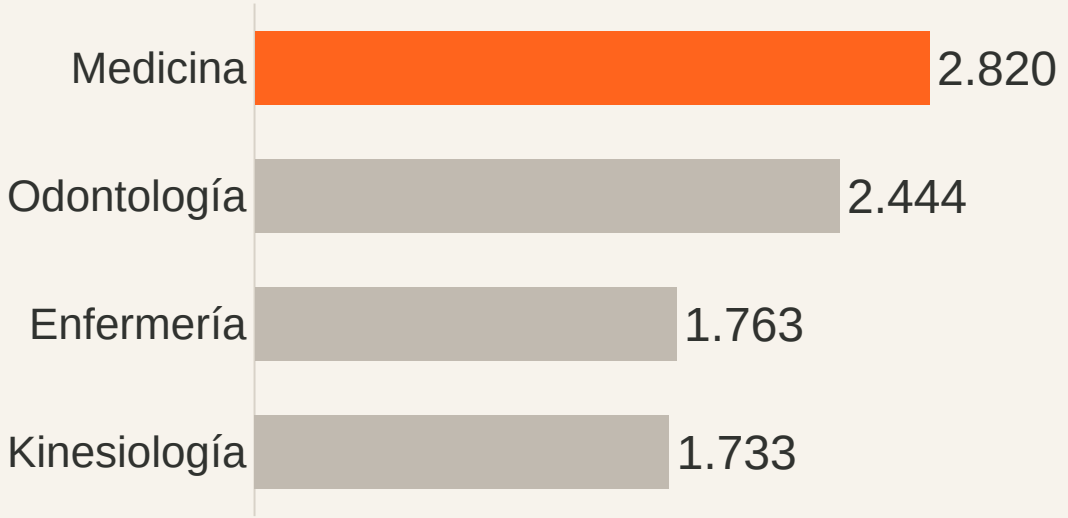
inasistencias en 144.800 citas candidatas

11,42 %

tasa candidata · enero–julio de 2026

No toda inasistencia libera un cupo
ni toda reasignación termina en atención.

Mayor volumen de inasistencias

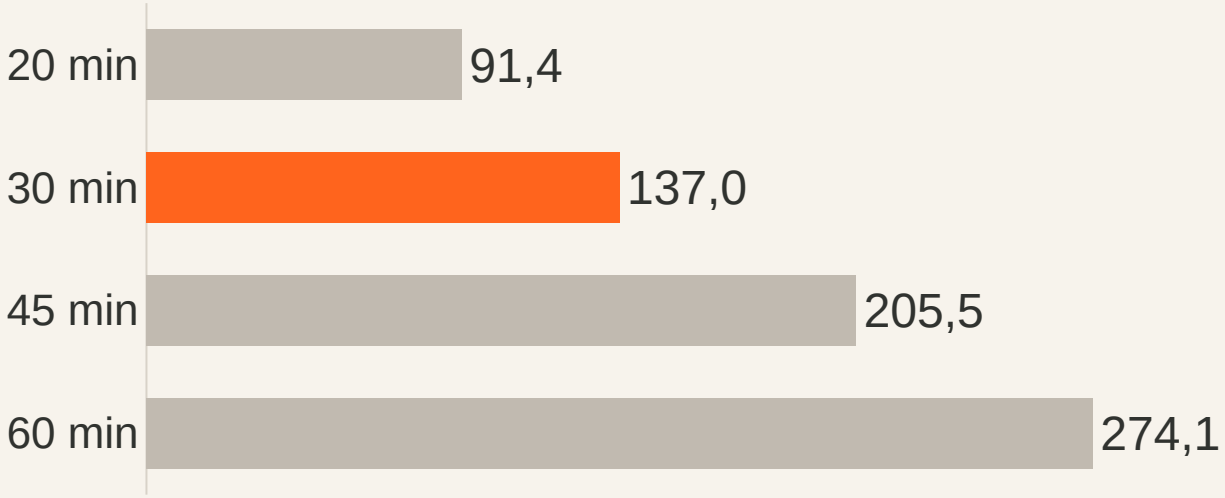


El valor: aprovechar cupos liberados de forma segura, compatible y trazable.

La duración cambia el valor de la capacidad.

Gasto total absorbido · millones de CLP

Supuesto uniforme de duración por atención



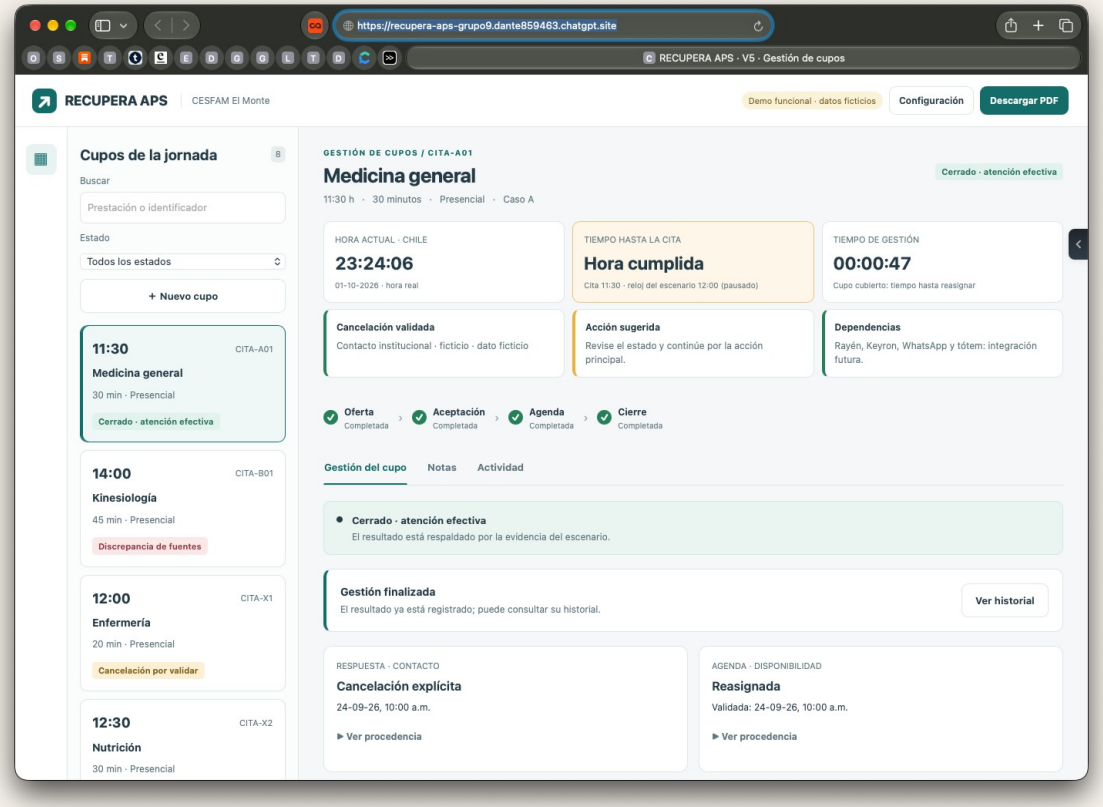
No conocemos aún la mezcla real de duraciones de los cupos elegibles y las reasignaciones.

Si se aprovechara…

ESCENARIO A 30 MIN	VALOR
25 %	$34,3 M
50 %	$68,5 M
75 %	$102,8 M

Escenarios, no ahorro demostrado. El piloto medirá duración, elegibilidad, asistencia y costo de gestionar.

V5 hace visible la decisión y deja su recorrido.



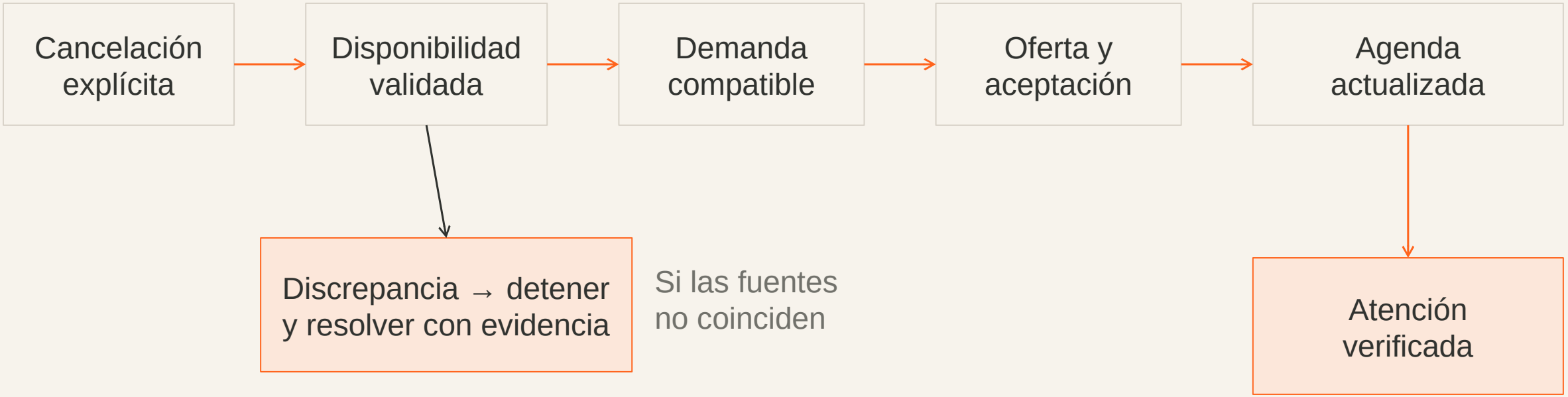
8 casos sintéticos

Disponibilidad, compatibilidad, oferta, agenda y cierre.

Reglas explicables.
Decisión humana.
Registro de evidencia.

Sin integraciones productivas ni envíos reales desde la demo.

Recuperar un cupo exige confirmar cada transición.



SIN RESPUESTA

Se conserva la cita original.

NO BASTA CON ACEPTAR

El cierre exige verificar la atención.

Tres pruebas. Una misma regla: no cerrar sin evidencia.

01 / CASO RESUELTO

Recorrer un cupo

Validar → ofrecer → aceptar → actualizar agenda → verificar la atención.

02 / DISCREPANCIA

Mostrar el bloqueo

Contrastar fuentes. Detener el avance hasta resolver la diferencia.

03 / SIN RESPUESTA

Proteger la cita original

El silencio no autoriza a liberar ni reasignar un cupo.

Abrir prototipo V5 →

Plan B: video local · 2 min 35 s

V5 cierra la etapa académica. El impacto se mide en operación.

LO QUE YA TENEMOS

Pruebas del prototipo y recepción favorable

Sesiones internas e iteraciones V2–V5. El equipo reporta V5 validado para la etapa académica.

Aún no equivale a integración productiva ni a impacto asistencial demostrado.

LO QUE DEBE MEDIR EL PILOTO

Atención efectiva
Atendidos / cupos elegibles

Seguridad y adopción
Incidentes, bloqueos y uso por SOME

Sostenibilidad
Minutos de gestión, costo y carga

Datos y equidad
Duración, trazabilidad y canales

Proponemos a la Dirección de Salud un piloto acotado y supervisado.

Condicionado a autorizar datos, sistemas, reglas operativas, responsables y resguardos institucionales.

01 / PREPARAR

Acordar las condiciones

Alcance y fuente oficial.
Roles, permisos y privacidad.
Capacitación y contingencia.

02 / PILOTEAR

Operar con supervisión

Horizonte sugerido: 60–90 días.
Cupos y prestaciones acotados.
Medición y revisión periódica.

03 / DECIDIR

Evaluar antes de escalar

Continuar, corregir, ampliar o detener según evidencia y umbrales acordados.

Cuatro duraciones. Cuatro formas de valorizar la capacidad.

DURACIÓN	HABERES	PERSONAL TOTAL	PERSONAL + BIENES	GASTO TOTAL
20 min	60.345.549	74.869.929	83.255.994	91.352.915
30 min	90.518.324	112.304.893	124.883.990	137.029.373
45 min	135.777.486	168.457.340	187.325.986	205.544.059
60 min	181.036.648	224.609.787	249.767.981	274.058.745

A 30 minutos: $112,3–137,0 millones

Personal total → gasto total absorbido. Sensibilidad de valorización, no ahorro ni mezcla observada.

Cada riesgo necesita un control y una autoridad definida.

RIESGO	CONTROL ANTES / DURANTE EL PILOTO	AUTORIDAD A RATIFICAR
Liberación o doble asignación	Cancelación explícita + disponibilidad confirmada. Discrepancia: detener, resolver y registrar.	SOME + responsable de agenda
Incompatibilidad clínica	Reglas de elegibilidad, reconversión y viva voz autorizadas; sin decisión autónoma.	Jefatura clínica
Privacidad o acceso indebido	Datos mínimos, permisos por rol y trazabilidad. Demo sintética; uso real sólo autorizado.	Responsable de datos + TI
Sobrecarga o exclusión	Capacitación, canales alternativos, contingencia y medición de esfuerzo y acceso.	Dirección + SOME
Costo mayor que beneficio	Atención efectiva, tiempo de gestión e incidentes. Umbrales de continuidad y detención previos.	Dirección de Salud

Evidencia trazable. Herramientas declaradas.

BASES DE LA PRESENTACIÓN

01 Dossier final de trabajo · v0.1

Validación V5, captura y recomendación.

02 Clase 6 · Decisión, métricas y roadmap

Condiciones, medición y ruta institucional.

03 Informe No Show · v0.6

Línea base y sensibilidad financiera (§8–9).

USO DE IA EN ESTA EDICIÓN

HERRAMIENTA / PROPÓSITO	SALIDA Y VERIFICACIÓN
Codex · edición y diseño	Guion, gráficos y PPTX. Cotejo con las bases.
Generación de imágenes · arte	Portada abstracta. Revisión visual; no evidencia.
NotebookLM · antecedente	Antecedente revisado. No es fuente de cifras.

Para la sesión

PDF · enlace V5 · video ≤3 min · fuentes
Todo el equipo interviene o responde.